

Tuberculose · diagnóstico, TRM e PQT

TB pulmonar: tosse "e2–3 semanas pede investigação. TRM-TB agiliza diagnóstico e resistência à rifampicina; tratamento básico é RIPE supervisionado.

Esquema básico (conceito)

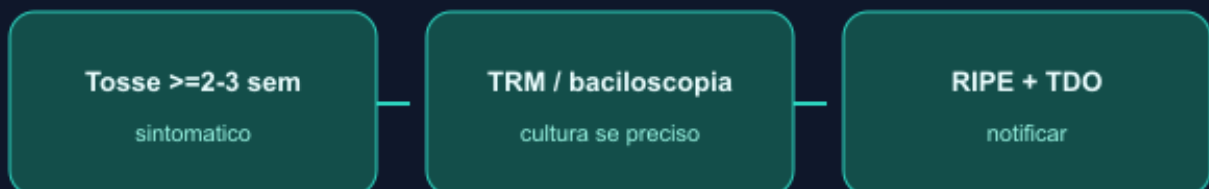
Lembre - Esquema básico (conceito)

2 meses RHZE + 4 meses RH no adulto sensível (doses/ajuste pediátrico e situações especiais conforme Manual MS). TDO melhora adesão.

Busca ativa na APS + confirmação laboratorial + início precoce do esquema.

Sintomático respiratório

Rastrear -> TRM/escarro -> tratar



Pontos high-yield

- Notificação compulsória; examinar contatos; TLT (IGRA/PPD) em elegíveis
- HIV: testar todo caso de TB; ajustar timing de TARV
- Extrapulmimar: pensar em miliare, meníngea, pleural — cultura/histologia
- Falha/resistência: TRM com rifampicina resistente !' referência

Ferramentas diagnósticas

Teste | Papel

TRM-TB | Diagnóstico rápido ± rif-R

Baciloscopia | Acompanhamento / disponibilidade

Cultura + TS | Padrão e resistência

Rx tórax | Apoio; não confirma sozinho

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não suspenda RHZE por 'hepatite leve' sem critérios — mas hepatotoxicidade grave exige conduta específica. Contato de TB bacilífera: avaliar TLT; BCG não trata infecção latente.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1